患者入选与禁忌

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

适应证

以传统白内障手术入选标准为主，患者能主动配合、角膜透明、睑裂正常，没有影响飞秒正常操作的情况。

2018 刊 p328 / PDF1

不能接受手术的情形

解剖异常无法操作、不能固视 / 仰卧配合、妨碍压平的角膜病（非接触设备除外）、阻挡激光的混浊、后弹力层膨出、近期反复角膜感染、前房血液 / 硅油、低眼压或角膜植入物。

2018 刊 p328 / PDF1

须严密评估

小睑裂、散大瞳孔直径 <5 mm 或异位、未控制青光眼 / 薄壁滤过泡、肥厚翼状胬肉 / 严重结膜松弛、晶状体明显异位。

2018 刊 p328 / PDF1

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

特殊情况与术前检查

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

特殊患者

硬核、功能性 IOL 、浅前房 / 全白内障、内皮病、部分半脱位 / 高度近视可考虑 FLACS ； 半脱位严重且切囊区被虹膜遮挡，不建议飞秒切囊。

2018 刊 p328–329 / PDF1–2

术前病史与常规检查

至少一次详细眼科检查：病史 / 药物过敏、期望、视力、散瞳前后前节、眼底、眼压、生物测量与 IOL 度数。

2018 刊 p329 / PDF2

按需特殊检查

角膜内皮、地形图、前节分析、干眼检查、对比 / 眩光敏感度、后节 OCT ； 依主诉和常规检查结果选择。

2018 刊 p329 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

操作顺序与切囊参数

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

基本操作顺序

知情同意 → 散瞳及 NSAID → 头位 / 表麻 → 前节成像与参数定位 → 切囊 → 预劈核 → 可选角膜切口 → 超乳及 IOL； Z8 可在劈核后切囊。

2018 刊 p329 / PDF2

切囊直径

可设 4.5 ～ 6.0 mm ，通常 5.0 ～ 5.2 mm ；硬核或拟植入可调节 IOL 可用 5.5 mm 。原则 360° 覆盖 IOL 边缘，撕囊边缘距瞳孔缘按原文 1 mm 安全范围。

2018 刊 p330 / PDF3

术者与环境

设备须获注册；建议主治及以上、有超乳经验；手术室 18 ～ 24 °C 恒定、相对湿度 <50% ，按设备及环境消毒要求执行。

2018 刊 p328 / PDF1

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

预劈核和角膜切口选择

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

预劈核选择

IV级及以上硬核强烈建议预劈核，可劈 6 块；并非所有病例必需。后极性白内障暂不建议预劈核；参数按核硬度、方式、设备个体化。

2018 刊 p330 / PDF3

角膜切口与散光

透明角膜切口不是必需；可用两 / 三平面，明显前移或定位困难可改手工。规则散光 1.00 ～ 1.50 D 或散光 IOL 残余此范围，可考虑松解切口。

2018 刊 p330 / PDF3

缺项与证据边界

原文部分优势来自其引用研究，不能写作所有患者必然获益；未统一给出激光能量 / 劈核深度、儿童妊娠方案及正式推荐分级。

2018 刊 p328–330 / PDF1–3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

缩瞳预防与术中处理

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

缩瞳预防用药

术前 1 h 内散瞳并联合 NSAID； NSAID 术前 1 d 点眼 3 或 4 次、每次 1 滴。激光后立即 1% 复方托吡卡胺 1 滴；推荐 15 ～ 20 min 内超乳。

2018 刊 p330–331 / PDF3–4

术中难散瞳

可前房注射 1：10 000 ～ 1：50 000 稀释肾上腺素，和 / 或机械扩瞳；注射体积、所有药物具体品种及完整禁忌原文未明确。

2018 刊 p330 / PDF3

负压固定异常

脱吸或异常气泡 / 结膜进入等 → 迅速松脚踏终止操作，休息后重新放置；多次无法固定可终止激光改常规超乳。

2018 刊 p330 / PDF3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

切囊、后囊安全及随访

飞秒激光辅助白内障手术规范 · 2018 专家共识

切囊不全 / 撕裂

切囊不全手法二次撕囊；不确定是否完整，可染色后取出，避免突然快速取囊。已撕裂则维持前房、轻巧操作并避开裂区。

2018 刊 p331 / PDF4

后囊与囊袋阻滞

保守扫描深度，关注眼位倾斜；减少气泡，移除囊膜前避免过量黏弹剂，水分离前囊袋减压。后极性合并硬核水分离尤其谨慎。

2018 刊 p331 / PDF4

眼表与术后随访

术前 / 早期术后评估干眼，酌情人工泪液；术后 1 d 、 7 d 、 1 个月复查视力、眼压和前房；并发症增频、异常及时就诊。

2018 刊 p331–332 / PDF4–5

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程｜飞秒激光辅助白内障手术规范

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2018

1 适应证与禁忌筛查

能配合、角膜透明且无禁忌？否 → 不进入 FLACS；小瞳 <5 mm 等 → 严密评估。

2018 刊 p328

2 术前检查与决策

常规眼科 / 生物测量；按需内皮、地形图、干眼与 OCT；个体化知情同意。

2018 刊 p328–329

3 用药与对接

散瞳 +NSAID 、表麻、固定、前节成像定位；脱吸 / 异常 → 立即停激光并处理。

2018 刊 p329–331

4 切囊与可选步骤

通常切囊 5.0 ～ 5.2 mm；预劈核 / 角膜切口按条件，后极性暂不预劈核。

2018 刊 p330

5 超乳及 IOL

推荐激光后 15 ～ 20 min 内超乳；切囊不全手法完成，水分离前减压、防后囊损伤。

2018 刊 p330–331

6 术后随访

1 d 、 7 d 、 1 个月检查视力 / 眼压 / 前房；异常或并发症 → 及时就诊、增加随访。

2018 刊 p331–332

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。